

KARTA INTERWENCJI NAGŁEJ – OCENA STANU KLINICZNEGO

DANE IDENTYFIKACYJNE PACJENTA: ID: PAC-404 | Kobieta, lat 41

OKOLICZNOŚCI PRZYJĘCIA: Pacjentka przywieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego w asyście służb porządkowych na wniosek zaniepokojonej rodziny.

OPIS ZDARZENIA I WYWIAD:

Według relacji osób bliskich od około dwóch tygodni obserwowana jest narastająca dezorganizacja zachowania. Pacjentka drastycznie ograniczyła przyjmowanie płynów i pokarmów, izoluje się w swoim pokoju. Całkowite zaniechanie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych i higienicznych. Obecnie kontakt werbalny jest zniesiony (mutyzm). Przed utratą kontaktu słownego pacjentka zgłaszała fałszywe, niepoddające się korekcji przekonania o byciu systematycznie podsłuchiwaną przez systemy wentylacyjne.

OBIEKTYWNY STAN KLINICZNY:

Brak współpracy podczas próby nawiązania kontaktu. Wyraźne usztywnienie postawy ciała i maskowata mimika twarzy (stan zahamowania ruchowego). Badanie neurologiczne i parametry życiowe (RR, HR, saturacja) w normie, co wstępnie wyklucza ostre tło toksykologiczne i somatyczne. Ewidentne zaburzenia procesów poznawczych oraz interpretacji rzeczywistości (aktywne objawy wytwórcze).

WNIOSKI I DECYZJE TERAPEUTYCZNE:

- Z powodu bezpośredniego zagrożenia życia wynikającego z odmowy przyjmowania pokarmów oraz pogłębionej dezorganizacji, pacjentka wymaga bezwzględnej hospitalizacji w trybie nagłym na oddziale całodobowym o wzmożonym nadzorze (warunki zamknięte).
- Konieczność pilnego wdrożenia leczenia celowanego, w tym preparatów modulujących gospodarkę neuroprzebiegową (antagoniści receptorów dopaminowych o przedłużonym uwalnianiu).
- W przypadku braku reakcji na wdrożoną farmakoterapię i utrzymywania się opornego stanu zahamowania (katatonii), wskazana kwalifikacja do zabiegów neuromodulacyjnych z użyciem kontrolowanych impulsów elektrycznych.